

NOTULEN

HARI / TANGGAL : Rabu / 19 November 2025
 PUKUL : 09.00 – 12.00 WIB
 AGENDA RAPAT : Rekredensialing BPJS Kesehatan Tahun 2026

PEMIMPIN RAPAT : Tim BPJS Kesehatan Cabang Malang
 NOTULIS : Mahesa Yudistiranti, S. AP
 TEMPAT : Hall Sakura Lantai 5

Berikut hasil notulen :

NO	POKOK BAHASAN	MASALAH	TINDAK LANJUT	PIC
1.	Note dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang	1. Rekam Medis terhubung Satu Sehat dengan pendataan dan diagnostik sudah sesuai → pemeriksaan laboratorium dan radiologi belum terhubung Satu Sehat 2. Undang undang nomor 11 tahun 2025 rumah sakit berbasis kompetensi Sinkronisasi 24 layanan (jantung, urologi neunatus, saraf) masih belum terhubung 3. Monitoring Safety box apabila penuh maka segera di buang 4. Izin operasional akan diberlakukan seumur hidup 5. Laporan INM IKP untuk selalu update info perkembangan di grup <i>Whatsapp</i> 6. Rujukan respon igd cukup cepat baik - harapannya saling berbenah 7. Penggunaan SISROUTE mohon diaktifkan kembali	1. Target akhir tahun 2025 dihubungkan Satu Sehat 2. Perlu konfirmasi kembali dari pihak Dinas Kesehatan ke pimpinan untuk Rumah Sakit yang masih separuh terhubung separuh sudah 3. Mohon PPI memperhatikan kembali 4. Lakukan evaluasi dan Bimtek untuk pertauran yang baru 5. Target tahun depan RME sudah diterapkan 6. Jika ada kendala dalam penggunaan SISROUTE mohon dilaporkan	1. Kabid Pelayanan Medis 2. IGD 3. PPI 4. Mutu 5. PJ Sisrute
8.	Note dari PERSI	1. Ruang Isolasi IGD perlu tambahan anterroom 2. Tirai IGD yg merah bisa diganti warna lain, agar apabila terkena darah tidak terlihat 3. ICU pertimbangkan tambah anterroom 4. Monitoring tekanan oxygen central di ruangan cek kembali	1. Dipertimbangkan kembali untuk penambahan anterroom 2. Evaluasi pergantian tirai untuk diajukan ke PT 3. Di ICU pertimbangkan pindah pintu kamar mandi dan tata lagi	1. Kabid Pelayanan Medis 2. Kepala Bagian Umum 3. IGD 4. ICU



		5. SK TT diperbaiki supaya data dapat diterima oleh Kemenkes	4. Koordinasi dengan Samator untuk ruangan-ruangan yang butuh tekanan tinggi 5. SK TT diperbaiki	5. IPSRS
9.	Note dari BPJS Kesehatan	1. Sarana dan prasarana sudah baik, nyaman dan bersih 2. Identifikasi obat-obatan rutin dinotifikasi dalam SIMRS → dijadikan data potensi PRB → Sistem informasi di farmasi dibuat data potensi PRB untuk disampaikan ke DPJP 3. Waktu pelayanan antrian poli sudah baik kurang dari 50 menit untuk memangkas antrian di pendaftaran di tambahkan admisi (face recognition dan Fingerprint) di area poli, dan untuk tensi pasien tidak saat sudah d ruang dokter agar waktu layanan tidak memanjang 4. Antrian MJKN sudah berjalan baik 5. Farmasi antrean sudah baik. Sempurnakan lagi untuk validasi di poli, obat yang ditinggal dan ditunggu. Sehingga antriannya akan membedakan untuk yang ditunggu bisa dikerjakan dahulu. Agar data e resep yang dikirim final dan tidak perlu konfirmasi ke farmasi → tujuannya untuk cepat pelayanan di poli dan farmasi 6. Obat near ed dan reagen bisa dimasukkan dalam SIMRS untuk mengetahui obat yang akan habis kurang dari 6 bulan dan Reagen yang akan Exp 7. Penyesuaian TT pada ruang Total 130 dikarenakan untuk prosentase TT intensif ICU 6% dan Intensif lainnya 4% dan apabila decimal maka pembulatan keatas (5,12 jadi 6) dan Ruangan Intensif lainnya NICU dan	1. Notifikasi obat near ED di SIMRS koordinasi dengan Programmer PT 2. SK TT diperbaiki sesuai dengan arahan BPJS Kesehatan 3. Evaluasi pergantian tirai untuk diajukan ke PT 4. Evaluasi eye wash untuk diajukan ke PT 5. Monev terkait komitmen jadwal DPJP sesuai HFIS → Jika ada ijin lama bisa digantikan dokter lain → Kolaborasi Kabid Pelayanan Medis dan Sekre Komite Medik 6. Evaluasi penggunaan password doorlock di Ruang Perinatologi 7. Rujukan dari Klinik Mutiara Sehat lakukan Monev supaya tidak menjadi anomali. 8. Karyawan RS yang periksa di RS harus sesuai alur yang berlaku	1. SPI 2. Kabid Pelayanan Medis 3. Programmer PT 4. IFRS 5. Laboratorium



		PICU wajib memiliki ventilator 1:1 sehingga penyesuaian sbb : 1) NICU semula 3 TT dengan 1 Ventilator menjadi 2 TT dengan 2 Ventilator 2) HCU semula 1 TT menjadi 2 TT HCU, sehingga menjadi 3TT 3) Perina semula tidak masuk dalam SK TT wajib dimasukkan dan menjadi penambahan SK TT (perina 2TT) 4) Ruang rawat inap kelas 1 semula 20 menjadi 18 (menggantikan ruang perina yang masuk dalam TT) 8. Tirai di rawat inap wajib menggunakan bahan yang waterproof (belum waterproof) 9. Jadwal DPJP harus komitmen sesuai dengan jadwal yang ada di HFIS selama setahun 2026 10. Evaluasi Rujukan Mutiara Sehat terbanyak ke RS Prima Husada karena terafiliasi yang berpotensi data anomali (apabila tidak sesuai dan diaudit) 11. Tidak diperkenankan adanya poli pegawai, yaitu karyawan RS yang melakukan kunjungan ke IGD tetapi tidak sesuai ketentuan.		
--	--	---	--	--

Mengetahui,
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Resti Lestantini, M. Kes)

Malang, 20 November 2025
Notulis

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatanganan Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

(Mahesa Yudistiranti, S. AP)

DOKUMENTASI

